

# PROTOCOLO INSUFICIENCIA CARDÍACA en UOME Hospital San Agustín de Avilés

Servicio Urgencias  
Ana Castro Fuertes

## 1. OBJETIVO GENERAL

- Estabilización y mejora de pacientes con descompensación aguda leve-moderada de IC en los que persisten síntomas/signos que no permiten alta directa desde SUH; mediante un tratamiento estandarizado y un control evolutivo de >24h.

### Objetivos secundario:

- Crear un protocolo de tratamiento y control para los pacientes con IC agudizada que no cumplen criterios de hospitalización, de manera multidisciplinar entre UOME del SUH, HAD y CAR

## 2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN

IC conocida (o probable) descompensada con:

- Persistencia de la clínica de congestión
- Disnea leve-moderada que no precise VMNI
- Hipoxemia que no precise VMNI
- Necesidad de tratamiento IV
- Plan terapéutico claro

## 3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

- Disnea en reposo NYHA IV
- Hipoxemia clínica relevante = insuficiencia respiratoria
- Necesidad de VMNI
- Inestabilidad hemodinámica, shock o hipotensión
- Necesidad de inotrópicos/vasopresores
- Edema agudo grave
- Arritmia grave (descompensa enfermedades de base, inestabilidad)

## 4. EVALUACIÓN INICIAL SUH → UOME

### 4.1. Indicadores de calidad asistencial descritos:

- ETT durante ingreso
- Registro FEVI y clasificación fenotípica
- Determinar biomarcadores
- Evaluación del hierro
- Inicio de 4 pilares antes del alta
- Cita precoz post-alta
- Educación terapéutica

### 4.2. Objetivos diagnósticos en Urgencias:

El diagnóstico combina clínica, analítica y pruebas de imagen y la evaluación inicial debe perseguir unos objetivos:

- Confirmar/descartar presencia de IC descompensada
- Identificar factores precipitantes
- Detectar situaciones de riesgo vital inmediato
- Establecer perfil clínico-hemodinámico del paciente (congestión/perfusión/PA)
- Determinar destino asistencial más adecuado: Alta SUH, UOME, HAD, Hospitalización (UMIPIC/CAR)

### 4.3. Datos a registrar:

- Disnea y capacidad funcional: mMRC + NYHA
- Oxigenación Sat/pO<sub>2</sub>
- Signos congestión pulmonar/sistémica
- Presentación clínica / clasificación fenotípica
  - IC de novo
  - IC en descompensación aguda
  - Insuficiencia ventricular derecha aislada
  - *Las presentaciones de EAP y Shock cardiogenico son criterios de exclusión*
- FEVI
- Tratamiento diurético actual
- Peso

### 4.4. Pruebas complementarias

- *ECG y tira de ritmo*
- *Analítica*
  - Hemograma
  - Coagulación
  - BQ con función renal, na-K, Cloro, ferritina, NtproBNP
  - TSH
  - Antígeno carbohidrato 125
- *Rx tórax*
- *ETT previa (fecha y resultados de FEVI, valvulopatias y HTP)*

## TRATAMIENTO

**1. Oxigenoterapia:** Si Sat <90% o PaO<sub>2</sub> <60mmHg. Evitar oxígeno rutinario

### **2. Diuréticos:**

Objetivo aliviar congestión y alcanzar euvolemia, evitar alta con congestión residual.

#### 2.1. Furosemida IV

- *Dosis:*
  - Pacientes naive: 20-40mg IV
  - Pacientes previamente tratados: De 1 a 2'5 veces dosis total domiciliaria IV (independientemente de la TA)
- *Objetivo:* Diuresis >100-150ml/h primeras horas y balance negativo
- *Monitorización del tratamiento:*
  - Registrar Balance hídrico + analítica control con Iones en orina 6h
  - Respuesta satisfactoria:
    - ✦ contenido Na+orina 70 mEq/l a las 2 h ó
    - ✦ diuresis > 600-900ml durante las primeras 6 h.
  - Respuesta insuficiente → ingreso

### **3. Hierro carboximaltosa IV:**

SOLO SI ferritina <100ng/ml o 100-299ng/ml + sat transferrina <20%

\* L-V horario laboral: actuar según resultado

\* L-V tardes/noches o fines de semana: Dejar solicitud, imprimir volante de solicitud previa de BQ y añadir a mano solicitud de hierro, comunicar a LAB.

# DESTINO AL ALTA

## 1. ALTA A DOMICILIO

- Cumple criterios de respuesta satisfactoria al diurético
- Mejoría de la congestión / disnea siempre NYHA <IV que es motivo de hospitalización
- Ausencia hipoxemia (candidato HAD) o insuficiencia respiratoria no basal (hospitalización)

\* INT previa a UMIPIC: Valoración previa por su parte, al inicio de la observación si el paciente acude de 8-15h o al final de la estancia si acudiese de 15-8h.

## 2. HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

- Criterios clínicos
  - Respuesta subóptima a diuréticos en paciente estable sin complicaciones hemodinámicas (hipoPA, shock, EAP, arritmia grave) con diagnóstico de ICA que ya han sido estudiados previamente o bien que están pendientes de pruebas complementarias (valorados previamente por UMIPIC o CAR)
  - Pacientes descompensados por factor precipitante corregible (HTA, FA, infección)
  - Pacientes con IC terminal que se considere que deban ingresar para tratamiento paliativo cuando se hayan desestimado otras opciones terapéuticas
  - Agudizaciones de IC con respuesta parcial inicial en pacientes crónicos complejos que precisen un seguimiento al alta por su complejidad.
- Criterios logísticos y sociofamiliares: los habituales de HAD
- Criterios de exclusión:
  - BAV 2ºgrad o BAV completo o fallos MP
  - Angina inestable o IAM en ultimos 3 meses
  - Anomalía grave: Na <123 o >156, K < 2'5 o > 6, pH <7'30 o >7'45
  - Signos de gravedad: mala perfusion periferica, taquipnea >30rpm, obnubilado
  - IC de etiologia no filiada (sin estudios previos ni pendiente de estudios)
  - Que no cumple criterios clínicos o sociofamiliares

## 3. INGRESO EN HOSPITALIZACIÓN

- Respuesta diurética insuficiente con aceptable situación clínica (no insuficiencia respiratoria, hemodinamicamente estable) pero no cumple criterios logísticos de HAD
- No cumple resto de criterios de otros destinos o ya tenia criterios de exclusión iniciales